

Rapport psychiatrique et psychologique — Xavier BOUBERT

Date du rapport : 8 août 2026 **Rédaction :** Claude (Anthropic) — synthèse documentaire et analyse critique, projet « Psy » **Version :** 2.0 — révisée le 8 août 2026 après compléments anamnestiques rapportés directement par Xavier (situation familiale 2025-2026, parcours professionnel, syncopes, historique pharmacologique, aphantasie, épisodes dépressifs rétrospectifs, thérapies passées, absence de crises inattendues, pertes de parole en surcharge)

Cadre et limites. Ce document est une synthèse analytique produite par une intelligence artificielle à partir : (1) des documents cliniques réels du dossier (ressources/xavier/), (2) des critères du DSM-5 (ressources/spécialisées/), (3) de recherches bibliographiques en ligne (références en fin de document). Il ne constitue pas un acte médical et ne remplace ni une consultation ni une évaluation clinique. Le diagnostic médical de Trouble du Spectre de l'Autisme a, en tout état de cause, déjà été posé et confirmé par des médecins psychiatres (Dr Lamia Kias, 2023 ; Dr Jean-Baptiste Isorni, 21/11/2024) ; le présent rapport en vérifie la cohérence interne, l'article au DSM-5 et en tire des enseignements pratiques.

1. Sources utilisées

Source	Nature	Date
Compte-rendu d'évaluation psychologique — Emeline Saley, psychologue clinicienne (cabinet spécialisé TSA, Maisons-Alfort)	Évaluation clinique complète	05/04/2024
Dossier MDPH Cerfa 15692*01 + certificat médical du Dr Jean-Baptiste Isorni	Dossier administratif et médical	nov.–déc. 2024
Quotient du Spectre Autistique (AQ), réponses item par item	Auto-questionnaire	début 2024
Quotient d'Empathie (EQ / Cambridge Behaviour Scale), réponses item par item	Auto-questionnaire	début 2024
Échelle du syndrome d'Asperger (Garnett & Attwood), remplie par la mère	Hétéro-questionnaire	début 2024
Inventaire du stress (Grodén Center), avec réponses libres	Auto-questionnaire	10/01/2024
Questionnaire aux parents (réponses de la mère, Nicole Boubert)	Anamnèse familiale	début 2024
Compléments anamnestiques rapportés directement par Xavier (famille 2025-2026, travail, syncopes, traitements, aphantasie, shutdowns, thérapies passées)	Auto-anamnèse	08/08/2026

Source	Nature	Date
DSM-5 : TSA, TDAH, troubles anxieux et dépressifs, phobie spécifique	Référentiel diagnostique	—
Littérature scientifique en ligne (AQ/EQ, camoufflage, alexithymie, comorbidité anxieuse, HAS, venlafaxine, phobie sang-injection-accident et tension appliquée, aphantasie, shutdowns autistiques)	Recherche	août 2026

2. Fiche d'identification du patient

État civil

Champ	Donnée
Nom	BOUBERT (nom de naissance et d'usage)
Prénoms	Xavier, Louis, Pierre
Sexe	Masculin
Date de naissance	3 mars 1986
Lieu de naissance	Paris 20e (75), France
Nationalité	Française
Âge actuel	40 ans (au 08/08/2026) ; 38 ans lors de l'évaluation Saley et du certificat Isorni
N° de sécurité sociale	1 86 03 75 120 018 35 (cohérent : homme, né en mars 1986 à Paris 20e)

Situation familiale

Champ	Donnée
Statut	Divorcé (2012) ; en couple avec Chourouk Mrad depuis ≈ 2020 (relation qualifiée « en dents de scie » en avril 2024) ; mariés en 2025
Enfants	Deux filles : l'aînée née en 2012 (première union) — rupture de contact depuis septembre 2023 , l'adolescente ne souhaitant plus voir son père ; deux médiations tentées sans succès (elle ne s'est pas présentée à la seconde) ; la cadette née en 2026 (avec Chourouk)
Fratrie	Aîné de trois : Sandra (née 1987), Guillaume (né 1988) — liens fraternels décrits comme très soutenus et investis
Parents	Divorcés vers 1992-1993 (Xavier avait 6-7 ans). Mère : Nicole Boubert (elle-même élevée par la DASS ; sa mère est décédée d'alcoolisme quand elle avait 7 ans ; son père l'a abandonnée à la naissance — antécédents psychiatriques signalés côté maternel). Père : domicilié à Toulouse depuis le collège de Xavier. Relations parentales actuelles : maintenues à distance des deux côtés

Parcours scolaire et professionnel

Champ	Donnée
Scolarité	Maternelle et primaire à Guyancourt ; collège à Guyancourt (sixième redoublée ; brevet obtenu 10/20) ; lycée professionnel à Saint-Cyr-l'École : BEP puis Bac Professionnel Comptabilité
Profession	Développeur informatique / consultant en activité depuis la fin du lycée (salarié puis indépendant ; missions historiquement de 1 à 2 ans) ; fondateur de sa structure « Allons-y » en 2022 — freelance en télétravail complet , plusieurs missions simultanées (3 en cours en août 2026)
Particularité professionnelle	Compétence technique jamais mise en cause ; fins de mission récurrentes pour motifs relationnels (comportement social perçu comme « prétention, sarcasme, manque d'empathie »)
Permis de conduire	Obtenu en 2013

Santé et suivi

Champ	Donnée
Diagnostic principal	Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA), type Asperger , sans déficit intellectuel ni altération du langage — évoqué par le Dr Lamia Kias (psychiatre, février 2023), objectivé par Emeline Saley (psychologue, 05/04/2024), confirmé par le Dr Jean-Baptiste Isorni le 21/11/2024
Diagnostics associés (certificat Isorni)	Trouble anxieux ; agoraphobie ; crises d'angoisse aiguë (CAA) avec sensations de dépersonnalisation et de déréalisation ; trouble de la concentration / distractibilité
Traitement médicamenteux	Venlafaxine (IRSN), reprise le 07/08/2026 . Historique : aucun traitement avant 2024 ; venlafaxine instaurée entre avril et novembre 2024 ; passage à la paroxétine (ISRS) vers mi-2025, suivi d'une régression clinique ; retour à la venlafaxine le 07/08/2026, décidé après un double épisode syncopal en juillet 2026
Médecin assurant le suivi	Dr Jean-Baptiste Isorni, 2 rue Jean Houdon, 78000 Versailles (n° 10100971380) — suivi mensuel ininterrompu depuis 2024 . Entrée dans le suivi déclenchée par une syncope chez l'ophtalmologiste (collyre mydriatique → anticipation d'une crise d'angoisse → angoisse → évanouissement)
Antécédents de soins psychiques	Un psychologue à l'entrée au collège ; à l'âge adulte, thérapies avec Catherine Gazeau, psychologue (TCC + technique de mouvements oculaires évoquant l'EMDR) : effets importants mais temporaires (« quelques mois/années » de gain à chaque fois) ; réponse quasi hypnotique observée en séance (état « presque de transe » sur consigne oculaire vers le bas)

Champ	Donnée
Antécédents symptomatiques	Crises d'angoisse dans les transports en commun depuis l'âge de 17 ans (bus, RER, train, métro, aéroport) ; maux de ventre anxieux depuis le CM2 ; mouvements dépressifs dès le CM2 puis épisodes dépressifs probables récurrents au collège et au lycée (identifiés rétrospectivement : clinophilie, retrait) ; idéation suicidaire active à l'adolescence ; énurésie nocturne jusqu'à ~16 ans ; syncopes en contexte de soins (ophtalmologiste ~2024 ; juillet 2026 : pose de cathéter puis fin de biopsie hépatique) ; pertes transitoires de la parole en situation de surcharge (notamment lors de conflits avec Chourouk)
Dossier administratif	Demande MDPH (Yvelines) : RQTH + orientation marché du travail + aménagement de l'environnement de travail ; certificat signé via Doctolib le 05/12/2024, formulaire signé le 14/12/2024 ; motif d'urgence invoqué : risque de perte d'emploi lié à la fin du télétravail chez les clients
Événements médicaux récents	Biopsie hépatique en juillet 2026 (indication somatique non documentée dans le dossier), marquée par un double épisode syncopal : à la pose du cathéter, puis en fin d'examen
Particularité neurocognitive	Aphantasie auto-rapportée : absence d'imagerie mentale visuelle, imagination conceptuelle préservée (« j'ai de l'imagination, mais aucune image visible dans la tête »)

3. Chronologie diagnostique et de soins

Période	Événement
1986	Naissance à Paris 20e ; accouchement déclenché une semaine après le terme, sans complication
~1992-93 (6-7 ans)	Divorce parental ; séjour de 3 mois avec la mère en foyer pour femmes battues
~1996-97 (CM2)	Effondrement scolaire ; premiers « forts mouvements dépressifs » ; début des maux de ventre anxieux (somatisation toujours présente à l'âge adulte)
~1997-2002 (collège)	Sixième redoublée ; harcèlement (brimades, moqueries, exclusion) ; violences familiales ; idéation suicidaire récurrente (se met sur le rebord de la fenêtre, pieds dans le vide) ; privations éducatives sévères ; épisodes dépressifs probables (clinophilie : rester au lit sans pouvoir en sortir ni investir une activité pendant les vacances — identifiés rétrospectivement), qui se répéteront au lycée
~2002 (16 ans)	Fin de l'énurésie nocturne
~2003 (17 ans)	Premières crises d'angoisse dans les transports en commun — persistantes depuis (>20 ans)
~2004-06	BEP puis Bac Pro ; entrée dans la vie active (informatique)
2012	Naissance de sa fille ; divorce
Âge adulte	Thérapies avec Catherine Gazeau, psychologue (TCC + mouvements oculaires de type EMDR) : améliorations réelles mais temporaires — « quelques mois/années » de gain à chaque fois

Période	Événement
2022	Création de sa structure « Allons-y » : passage en freelance multi-missions, télétravail complet
Février 2023	Le Dr Lamia Kias (psychiatre, consultée sur orientation de sa sœur Sandra) évoque un syndrome d'Asperger
01/08/2023	Emménagement à Guyancourt avec Chourouk Mrad
Septembre 2023	Dernier contact avec sa fille aînée (11 ans), qui refuse ensuite de le voir ; deux médiations tenteront de renouer le lien, sans succès (elle ne se présente pas à la seconde)
10/01/2024	Inventaire du stress Groden (auto-passation)
05/04/2024	Évaluation psychologique complète — Emeline Saley : « TSA de légère intensité (DSM-5) / syndrome d'Asperger (DSM-IV) », à confirmer par un psychiatre. Aucun traitement médicamenteux à cette date
2024	Syncope chez l'ophtalmologiste (collyre mydriatique → pensée « je vais faire une crise » → angoisse → évanouissement) — événement déclencheur de la recherche d'un psychiatre , aboutissant au suivi avec le Dr Isorni
Avril → nov. 2024	Aggravation anxieuse : CAA avec dépersonnalisation/déréalisation, agoraphobie au premier plan, repli et isolement ; instauration de la venlafaxine ; début du suivi mensuel Dr Isorni
21/11/2024	Certificat médical du Dr Isorni : confirmation du TSA + trouble anxieux + agoraphobie
05-14/12/2024	Dépôt du dossier MDPH (RQTH, procédure simplifiée)
2025	Mariage avec Chourouk ; vers mi-2025, remplacement de la venlafaxine par la paroxétine (ISRS) — régression clinique progressive sur l'année qui suit
2026	Naissance de sa seconde fille
Juillet 2026	Biopsie hépatique avec double syncope : à la pose du cathéter, puis en fin d'examen
07/08/2026	Retour à la venlafaxine (décision motivée par la régression sous paroxétine et le double épisode syncopal)

Lecture de la trajectoire : le motif de consultation de toute une vie (mal-être, angoisses, crises dans les transports) a été traité pendant vingt ans comme un problème anxieux isolé, avec des thérapies dont les bénéfices réels s'érodaient en quelques mois ou années. Le substrat neurodéveloppemental n'a été identifié qu'à 37-38 ans, sur initiative familiale — séquence extrêmement typique des adultes TSA sans déficit intellectuel. La période 2025-2026 cumule des événements de vie majeurs (mariage, naissance, lien rompu avec l'aînée, parcours somatique avec biopsie, changement puis retour de traitement) : l'aggravation actuelle (syncopes, pertes de parole en surcharge) se lit comme la rencontre d'une vulnérabilité ancienne et d'une charge de vie exceptionnellement élevée — pas comme une dégradation inexpiquée (cf. §9.17).

4. Anamnèse synthétique

Développement précoce (source : mère)

Grossesse et accouchement sans particularité (déclenchement à terme + 1 semaine). Marche à 10 mois (précoce). Langage acquis aux âges attendus, sans retard — point important : il exclut la forme autistique avec altération du langage et oriente d'emblée vers le profil « Asperger ». Propreté diurne à 2 ans ½ ; **propreté nocturne vers 16 ans seulement**. Garde par assistante maternelle puis crèche. « Enfant adorable, rien de particulier » jusqu'à 3 ans.

Enfance et scolarité

Maternelle sans difficulté scolaire ; sur le plan social, **un copain exclusif** (mode relationnel qui se répétera à chaque étape : un ami unique et exclusif en primaire, au collège). Primaire : bonnes notes jusqu'au CM2, année de rupture (enseignante décrite comme malveillante) avec chute scolaire et premiers mouvements dépressifs. Loisirs solitaires et systématiques : livres-jeux, constructions, ordinateur, jeux vidéo ; sorties très rares. Collège : scolarité « chaotique », avertissements travail et conduite chaque année, sixième redoublée, harcèlement subi ; à la maison, violences physiques et verbales (père, mère, belle-mère) et grande précarité ; privé de ses divertissements, il **construit des jeux qu'il présente à ses camarades** — l'intérêt pour la création informatique résiste à tout. Lycée professionnel : investissement scolaire minimal mais intégration sociale correcte dans un petit groupe ; la fratrie s'auto-organise et les violences cessent. L'ordinateur (programmation, création, jeux vidéo) absorbe « une très grande majorité de son temps libre ».

Contexte familial

Exposition prolongée durant l'enfance à des violences intrafamiliales physiques et verbales, à la précarité, et à un climat conjugal explosif avant le divorce. Ce contexte constitue un **facteur traumatique autonome**, distinct du TSA, dont les effets propres (anxiété, dysrégulation émotionnelle, énurésie prolongée, dépression adolescente) se sont additionnés aux vulnérabilités neurodéveloppementales — et les ont probablement masquées.

Âge adulte

Insertion professionnelle continue et qualifiée (développement informatique), longtemps instable dans la durée pour motifs exclusivement relationnels, jusqu'à la **création de sa propre structure (« Allons-y », 2022)** : freelance en télétravail complet, plusieurs missions menées de front (3 en août 2026) — un aménagement auto-construit qui neutralise les deux principaux facteurs historiques de rupture (transports, immersion sociale continue). Vie affective : premier mariage puis divorce (2012) ; une fille aînée née en 2012, **avec laquelle le lien est rompu depuis septembre 2023** (deux médiations sans succès) ; **remariage avec Chourouk en 2025**, naissance d'une **seconde fille en 2026**. Cercle amical : **une seule relation amicale** en dehors de la famille et du couple. Autonomie complète dans la vie quotidienne (logement, conduite, gestion). Phénomène rapporté en situation de conflit ou de sur-sollicitation (notamment avec Chourouk) : **perte transitoire de la capacité à parler et à traiter la moindre demande** — profil typique du *shutdown* autistique (cf. §6.4). Xavier se décrit

par ailleurs **aphantastique** : aucune image mentale visuelle, imagination conceptuelle intacte (cf. §6.4 et §9.15).

5. Données psychométriques — avec re-cotation indépendante

Un apport spécifique de ce rapport : les réponses brutes item par item étant disponibles, l'AQ et l'EQ ont été **re-cotés indépendamment** à partir des clés de correction publiées (Baron-Cohen et al., 2001 ; Baron-Cohen & Wheelwright, 2004).

5.1 Autism-Spectrum Quotient (AQ) : 39/50 — re-cotation : 39/50 ✓ (accord exact avec Saley)

Repères : seuil clinique classique ≥ 32 (79-80 % des adultes Asperger/HFA au-dessus, ~2 % des témoins) ; moyenne des témoins $\approx 16,4$; moyenne des patients Asperger $\approx 35,8$. **Xavier, à 39, se situe au-dessus de la moyenne du groupe clinique autiste lui-même.** Des travaux ultérieurs (Broadbent et al., 2013) proposent un seuil de dépistage à 29+ ; Xavier le dépasse largement quel que soit le seuil retenu.

Décomposition en sous-échelles (re-cotation) :

Sous-échelle	Score /10	Lecture
Compétences sociales	10/10	Plafond absolu — chaque item est coté dans le sens autistique
Communication	9/10	Quasi-plafond
Bascule attentionnelle (rigidité/routines)	8/10	Très élevé
Attention aux détails	6/10	Modéré
Imagination	6/10	Modéré

Ce que ce profil apprend : l'autisme de Xavier est massivement **socio-communicationnel et « rigidité/routines »**, et non « systématiser » au sens du stéréotype : il déclare ne pas être fasciné par les chiffres (item 19), ni par les dates (9), ne pas collectionner d'informations par catégories (41), et inventer facilement des histoires (14). Ce profil sans les marqueurs « folkloriques » de l'autisme (calcul, trains, collections) est précisément celui qui échappe le plus longtemps au repérage — une des explications probables du diagnostic à 38 ans.

Note ajoutée en v2.0, à la lumière de l'**aphantasie** révélée en 2026 : sa réponse « tout à fait d'accord » à l'item 3 (« il est très facile de m'en représenter une image mentalement ») contredit en apparence l'absence d'imagerie visuelle. L'explication la plus probable : il a répondu au sens *conceptuel* (« concevoir, me représenter l'idée ») — les personnes aphantastiques découvrent typiquement très tard que « voir dans sa tête » est *littéral* pour les autres. Cotée au sens littéral, cette réponse basculerait

dans le sens autistique et porterait l'AQ à 40/50. L'item 8 (« imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler », coté lui dans le sens du déficit) est en revanche parfaitement cohérent avec l'aphantasie. La sous-échelle « imagination » (6/10) mélange donc deux fonctions dissociées chez lui : l'imagination (préservée) et l'imagerie (absente).

5.2 Empathy Quotient (EQ) : 9/80 — re-cotation : 9/80 ✓ (accord exact avec Saley)

Repères (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004) : moyenne des témoins ≈ 42 ; seuil ≤ 30 pour 81 % des adultes Asperger/HFA ; moyenne du groupe Asperger $\approx 20,4$ (écart-type $\approx 11,6$). **Un score de 9 est extrêmement bas : plus d'un écart-type sous la moyenne du groupe autiste lui-même.**

Mais l'analyse item par item révèle une structure que le score global écrase — et c'est probablement l'enseignement le plus important de tout le dossier :

La totalité des 9 points provient d'items d'empathie affective, morale ou d'engagement relationnel :

Item	Réponse	Points
11. « Cela ne m'ennuie pas trop d'être en retard à un rendez-vous fixé à un ami »	Pas du tout d'accord (= cela le heurte fortement)	2
12. « Les relations sociales sont si difficiles que j'essaie de ne pas m'en soucier »	Pas du tout d'accord (= il s'en soucie, malgré la difficulté)	2
18. Couper des vers de terre enfant « pour voir »	Pas du tout d'accord	2
38. « Ça me bouleverse de voir un animal souffrant »	Plutôt d'accord	1
50. Détachement émotionnel devant un film	Plutôt pas d'accord (= il s'implique)	1
54. Comprendre ce que quelqu'un veut dire	Plutôt d'accord	1

Et la totalité des zéros provient des items d'empathie cognitive : détecter qu'on veut entamer une conversation (1), repérer la gêne d'autrui (26), prédire les ressentis (25), deviner les émotions masquées (55), lire l'intérêt ou l'ennui (41), comprendre intuitivement les situations sociales (35, 52, 57, 58)...

Autrement dit : **le « manque d'empathie » unanimement rapporté (collègues, proches, ASDI, Attwood) est un déficit de *décodage* (empathie cognitive / théorie de l'esprit), pas un déficit de *souci d'autrui* (empathie affective).** Les items « filler » vont dans le même sens : convictions morales très fortes (20), refus absolu de l'illégalité (13). Cette dissociation empathie cognitive effondrée / empathie affective préservée est le pattern classique du TSA (et le distingue précisément de la psychopathie, où c'est l'inverse). L'étiquette sociale « froid, insensible, prétentieux » qui a coûté des missions entières repose donc sur un malentendu mesurable, démontré dans ses propres réponses.

5.3 Échelle du syndrome d'Asperger (Garnett & Attwood) — cotée par la mère

7 items sur 24 cotés ≥ 4 (dont trois à 6/6 : absence de modulation de l'expression émotionnelle, désintérêt pour les sports de compétition, indifférence à la pression des pairs ; et un 6/6 en communication : ne s'intéresse pas à ce que dit l'interlocuteur ; mémoire à long terme « exceptionnelle » 6/6). Section F : « **tendance à agiter ses bras ou à se balancer quand il est excité ou angoissé** » **cochée « oui »** — donnée précieuse : c'est la seule stéréotypie motrice documentée du dossier, rapportée par un tiers, portant sur l'enfance (critère B1 du DSM-5).

Points de discordance instructifs : la mère cote 0 tous les items « intérêts spécifiques » et « routines » de l'enfance, alors que l'adulte et la clinicienne les documentent abondamment. Trois lectures compatibles : (1) mémoire parentale lointaine et lacunaire (elle le dit elle-même) ; (2) chaos familial de l'époque, peu propice à l'observation fine ; (3) intérêts (lecture, constructions, ordinateur) socialement banals pour un garçon des années 90, donc invisibles comme signes. Le DSM-5 prévoit exactement ce cas : les symptômes « ne sont pas nécessairement pleinement manifestes avant que les demandes sociales n'excèdent les capacités limitées » et « la simple absence d'information développementale ne permet pas d'exclure le diagnostic ».

5.4 ASDI (entretien de Gillberg) — auto-complété

Résultats rapportés par Saley : D1 interactions sociales **3/4** ; D2 intérêts restreints **2/3** ; D3 routines **1/2** ; D4 particularités de parole/langage **1/5** ; D5 communication non verbale **2/5** ; D6 maladresse motrice **0/1**.

Mise en perspective avec les critères originaux de Gillberg & Gillberg (exigences : D1 ≥ 2 , D2 ≥ 1 , D3 ≥ 1 , **D4 ≥ 3** , D5 ≥ 1 , **D6 = 1**, les six domaines requis) : Xavier remplit **4 domaines sur 6** — il ne satisfait pas strictement les critères de Gillberg du syndrome d'Asperger (langage non pédant, aucune maladresse motrice), tout en satisfaisant pleinement les critères DSM-5 du TSA (qui n'exigent ni l'un ni l'autre). C'est une illustration concrète de la raison pour laquelle le DSM-5 a fusionné les anciennes catégories en un spectre unique : les profils réels chevauchent les frontières nosographiques. Limite méthodologique : l'ASDI est conçu comme entretien administré par le clinicien ; il a ici été auto-complété.

5.5 Inventaire du stress (Grodén) — profil de stress

Classement des catégories (moyenne /5) : **Social/environnement 3,67** > **Sensoriel/personnel 3,50** > Nourriture 3,33 > Rituels 3,25 > Changement 2,91 > Déplaisant 2,89 > Anticipation 2,57 > **Positif 1,50**.

23 items sur 62 cotés 4 ou 5. Items à 5 (stress sévère) les plus parlants pour la vie actuelle : proximité de gens bruyants ou dérangeants ; se déplacer d'un lieu à un autre ; attendre le transport ; changement de personnel (superviseur) ; se sentir envahi par les autres ; **peur des foules ; peur des endroits clos**.

Réponses libres — d'une grande valeur clinique, citées telles quelles :

- « Je fais des crises d'angoisse dans les transports en commun **depuis que j'ai 17 ans**. (Bus, RER, Train, Métro, Aéroport...). J'ai fait 2 thérapies, dont une cognitivo-comportementale, mais j'ai toujours ces angoisses. »
- Facteur le plus significatif : « **M'adapter aux autres** est sans doute ce qui est le plus stressant. Je pense que c'est ce qui déclenche mes crises d'angoisse [...] Le fait de ne pas avoir de comportement étrange, comprendre ce qu'on me dit et comment la personne attend que je lui réponde. **Mon esprit est focalisé sur ça, je ne sais jamais comment être**, aussi bien avec mes proches que dans le monde professionnel. »

Ce dernier paragraphe est, mot pour mot, une définition du **camouflage social autistique** (*camouflaging/masking*) : surveillance consciente et permanente de sa propre présentation sociale. La littérature récente montre que l'intensité du camouflage prédit l'anxiété, la dépression et l'épuisement chez les adultes autistes, indépendamment de l'intensité des traits autistiques eux-mêmes (Hull et al., 2021 ; revues systématiques 2025-2026). La lecture la plus cohérente du dossier : **les crises d'angoisse sont le coût du camouflage** — elles surviennent là où la charge d'adaptation est maximale et incontrôlable (transports = promiscuité sensorielle et sociale sans échappatoire ; réunions avec inconnus = décodage à haute intensité).

Détail à ne pas manquer : la catégorie la moins stressante est « Positif » (1,50) — les renforçateurs, félicitations et événements agréables ne coûtent rien. Le levier thérapeutique et managérial est donc entièrement du côté de la réduction des charges (sensorielles, sociales, d'imprévu), pas du côté de la « motivation ».

5.6 Tests cliniques en séance (Saley) — un pattern cohérent

Test	Résultat	Ce que cela mesure
What are they thinking (théorie de l'esprit en contexte)	Majorité comprise, quelques réponses en décalage, rires nerveux	ToM explicite, avec coût émotionnel visible
Faces Test (reconnaissance d'émotions faciales)	Nombreuses erreurs, y compris sur émotions simples	Décodage émotionnel direct — échoué
Faux pas (Baron-Cohen & Stone)	Aucune difficulté significative	Raisonnement social explicite, verbal — réussi
Situations sociales	Sans erreur, mais hésitations et « grandes réflexions »	Compensation effortful visible
Reading the Mind in the Eyes	Bon dans l'ensemble (quelques erreurs franches) — exercices similaires déjà pratiqués sur internet	Effet d'entraînement plausible

Le pattern est typique de l'adulte autiste intelligent et compensé : **les épreuves qui autorisent un raisonnement verbal, lent et explicite sont réussies ; les épreuves de décodage rapide et intuitif échouent** ; et la réussite se paie (hésitations, rires nerveux, lenteur). C'est l'exacte transposition expérimentale de sa phrase « mon esprit est focalisé sur ça ». À noter : l'échec au Faces Test contrastant avec un Eyes Test correct oriente aussi vers une composante d'**alexithymie** (cf. §9.2).

6. Analyse critérielle DSM-5

6.1 Trouble du spectre de l'autisme — 299.00 (F84.0)

Critère A — déficits persistants de la communication et des interactions sociales, dans des contextes variés (les 3 requis) :

- **A1. Réciprocité socio-émotionnelle : PRÉSENT.** Difficultés à joindre, entretenir et réciproquer les conversations (Saley) ; « ne sait pas comment entretenir une conversation » (AQ 26), ne détecte pas l'ennui de l'interlocuteur (AQ 31), tours de parole incertains au téléphone (AQ 33) ; ASDI D1 3/4 ; désintérêt conversationnel coté 6/6 par la mère ; reproches professionnels récurrents. Correspond à la description DSM-5 de l'adulte sans déficit intellectuel : « difficultés à analyser et répondre à des situations sociales complexes [...] souffrent des efforts et de l'anxiété secondaires à une évaluation consciente de situations sociales auxquelles la plupart des sujets répondent de façon intuitive ».
- **A2. Communication non verbale : PRÉSENT.** Expression faciale mobile mais « pouvant s'avérer très figée » ; expression générale parfois inappropriée au contexte ; voix peu modulée, monocorde, volume fort ; gestes parfois gauches/étranges (ASDI D5). Le contact oculaire globalement préservé n'infirmes rien : le DSM-5 précise qu'un « contact visuel relativement bon » peut coexister avec une « mauvaise intégration du contact visuel, de la gestuelle, de la prosodie et de l'expression faciale ».
- **A3. Développement, maintien et compréhension des relations : PRÉSENT.** Mode relationnel « un ami exclusif » à chaque âge ; cercle adulte réduit à une amitié hors famille/couple ; préférence marquée pour les activités solitaires ; conduites socialement inadaptées non perçues comme telles ; fins de mission répétées ; difficulté à ajuster le comportement aux contextes.

Critère B — caractère restreint et répétitif (2 requis ; 4 présents) :

- **B1. Stéréotypies motrices ou verbales : PRÉSENT (documenté).** Agitation des bras/balancement en excitation ou angoisse (mère, échelle Attwood section F) ; répétition verbale des mêmes contenus (AQ 39).
- **B2. Intolérance au changement, routines : PRÉSENT (massif).** « Je préfère tout faire continuellement de la même manière » (AQ 2), perturbation par les changements d'habitudes (AQ 25), planification systématique (AQ 43, EQ 56), impossibilité de se détendre avant d'avoir achevé le planifié (EQ 40), listes (EQ 51) ; maniérismes de rangement/ménage ; détresse face au désordre d'autrui (« le bazar de ma copine ») ; Groden : déplacement 5, changement de superviseur 5, environnement non familial 4 ; difficultés face aux imprévus (Saley).
- **B3. Intérêts restreints et fixes, anormaux en intensité : PRÉSENT.** Le développement informatique depuis l'adolescence, « envahissant », « primordial », absorbant l'essentiel du temps libre à chaque époque de la vie, avec passions satellites cycliques dans le même domaine ; se « tracasse » s'il ne peut s'y consacrer (AQ 16) ; hyperfocus au point de perdre l'environnement de vue (AQ 4, Saley).

- **B4. Hyper/hyporéactivité sensorielle : PRÉSENT (4 canaux).** Hypersensibilités tactile (contacts inconfortables, visage ; textures), auditive (bruits, bruits non identifiés), visuelle (lumières intenses, halogènes ; Groden 4), olfactive (majorité des odeurs pénibles, exception apaisante du lilas) ; détection de bruits discrets (AQ 5).

Critère C — présence dès les étapes précoces du développement : REMPLI, au sens exact du DSM-5 : signes relevés rétrospectivement en maternelle/primaire (ami exclusif unique, évitement de l'interaction en récréation, inconscience des conventions, indifférence aux pairs, absence de modulation émotionnelle — échelle Attwood ≥ 4 sur 7 items ; stéréotypies), pleinement manifestes quand les exigences sociales ont dépassé les capacités (CM2, collège), et « masqués plus tard dans la vie par des stratégies apprises » — le camouflage décrit en §5.5. La clause d'exclusion du DSM-5 (« relations amicales typiques et maintenues et bonnes capacités de communication non verbale » dans l'enfance) n'est pas satisfaite : c'est bien le diagnostic qui tient.

Critère D — retentissement cliniquement significatif : REMPLI. Professionnel (fins de mission à répétition durant toute la carrière salariée, ayant imposé une réorganisation complète en freelance-télétravail ; RQTH), social (isolement, « repli sur soi » au certificat), familial (rupture du lien avec sa fille aînée sur fond de conflit, tensions conjugales avec pertes de parole en surcharge), souffrance subjective (anxiété continue, crises, syncopes).

Critère E — non mieux expliqué par un handicap intellectuel : REMPLI. Langage acquis sans retard, parcours qualifié, autonomie complète, métier d'ingénierie.

Spécifications DSM-5 :

- **Sans déficit intellectuel associé** (à objectiver par WAIS-IV si souhaité) ;
- **Sans altération du langage associée** ;
- **Associé à un autre trouble mental : troubles anxieux (agoraphobie, attaques de panique) ;**
- Sévérité actuelle, cotée par domaine comme l'exige le DSM-5 : **communication sociale : niveau 1 « nécessitant de l'aide »** (s'exprime en phrases complètes, engage la conversation, mais échanges non réciproques et retentissement observable sans aide) ; **comportements restreints/répétitifs : niveau 1** (inflexibilité gênant le fonctionnement dans plusieurs contextes, difficultés de transition). Rappel textuel du DSM-5, important pour la MDPH : « Les catégories décrivant la sévérité ne doivent pas être utilisées pour décider de l'attribution de droits ou de services ; ceux-ci sont à déterminer à un niveau individuel. » « Léger » ne signifie donc ni « sans besoin » ni « sans souffrance ».
- Note DSM-5 explicite : « Les sujets ayant, selon le DSM-IV, un diagnostic bien établi de [...] syndrome d'Asperger doivent recevoir un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. » L'appellation « Asperger » utilisée par les trois cliniciens est donc, en nomenclature actuelle, **TSA sans déficit intellectuel ni altération du langage, niveau 1.**

→ **Conclusion : les critères DSM-5 du TSA sont remplis de façon complète et surdéterminée (A : 3/3 ; B : 4/4 alors que 2 suffisent).**

6.2 Troubles anxieux comorbides

Le DSM-5 note que les adultes TSA « ont tendance à développer des troubles anxieux et dépressifs » ; ~70 % des personnes TSA ont au moins un trouble mental comorbide, 40 % en ont deux ou plus (Simonoff et al., cité par le DSM-5). Méta-analyse adultes TSA (Hollocks et al., 2019) : prévalence vie entière ~42 % pour au moins un trouble anxieux.

a) Attaques de panique (spécification DSM-5). Les « crises d'angoisse aiguë » du certificat correspondent aux attaques de panique du DSM-5 : montée brusque de peur intense en quelques minutes. Point capital : « **Déréalisation (sentiments d'irréalité) ou dépersonnalisation (être détaché de soi)** » est le symptôme n° 11 de la liste officielle des 13 symptômes de l'attaque de panique. Les sensations de dépersonnalisation/déréalisation de Xavier ne sont donc ni un signe de psychose, ni un trouble dissociatif séparé (elles surviennent dans les crises) : elles sont un symptôme *attendu et répertorié* de l'attaque de panique, sans gravité neurologique propre — ce que les patients ignorent presque toujours et qui alimente la peur de « devenir fou » (symptôme n° 12). Sur la question distincte des **évanouissements** — qui ne sont *pas* l'évolution normale d'une attaque de panique — voir le point f) ci-dessous.

b) Agoraphobie — 300.22 (F40.00) : critères REMPLIS, diagnostic du Dr Isorni confirmé.

- **A** (peur/anxiété marquées dans ≥ 2 des 5 situations) : transports en commun (crises depuis 17 ans — bus, RER, train, métro, aéroport ; « attendre le transport » 5/5) ; files d'attente et foules (peur des foules 5/5, faire la queue 4/5) ; endroits clos (5/5) ; magasins (4/5). **Quatre situations sur cinq.**
- **B : confirmé explicitement en 2026** — « je dois sortir prendre du pain, je pense que je peux m'évanouir ». C'est mot pour mot la cognition du critère B du DSM-5 : crainte de la survenue de « symptômes de panique ou d'autres symptômes incapacitants ou embarrassants » dans des lieux d'où il serait difficile de s'échapper ou d'être secouru. Depuis l'apparition de syncopes réelles (juillet 2026), cette cognition dispose d'un « précédent » qui la renforce — d'où l'importance de traiter le versant vasovagal en propre (cf. point f).
- **C** : quasi-systématique (cotations 4-5 constantes, crises récurrentes depuis 20 ans).
- **D** : évitement actif — « difficulté à sortir en lien avec son agoraphobie » (certificat), exigence de télétravail, « stratégie d'évitement avec repli sur soi et isolement » (certificat).
- **E** : disproportion évidente. **F** : ~20 ans ($> > 6$ mois). **G** : retentissement professionnel majeur (RQTH). **H** : aucune affection médicale causale. **I** : non réductible à l'anxiété sociale (les transports et lieux clos sont craints même sans enjeu de jugement social) ni au TSA seul.
- Détail frappant : le DSM-5 indique « l'âge moyen global d'apparition pour l'agoraphobie est de 17 ans » — **l'âge exact du début des crises de Xavier**. Le DSM-5 précise aussi : évolution « persistante et chronique », rémission complète spontanée rare (~10 %) sans traitement — cohérent avec l'échec de deux thérapies non spécifiques — et facteurs environnementaux associés : « événements négatifs durant l'enfance », climat familial de faible chaleur. Tout concorde.

c) Trouble panique — 300.01 (F41.0) : ÉCARTÉ (question tranchée en v2.0). Le diagnostic exige des attaques **inattendues** récurrentes (sans déclencheur, y compris au calme). Xavier le confirme

directement : « je n'ai pas de crises d'angoisse *inattendues* ». Toutes ses attaques sont *attendues* (transports, situations sociales, contextes médicaux) : le tableau DSM-5 exact est donc **agoraphobie avec attaques de panique attendues** — pas de trouble panique. Précision utile à double titre : le traitement de première ligne est celui de l'agoraphobie (exposition graduée) et non un protocole spécifique du trouble panique, et l'absence de crises « venues de nulle part » est un élément pronostique rassurant.

d) Trouble d'anxiété généralisée — 300.02 (F41.1) : PROBABLE (réévalué à la hausse en v2.0).

L'élément qui manquait au dossier est désormais décrit par Xavier lui-même : des « pensées angoissantes **en continu, à chaque fois que je fais quelque chose** » — sortir acheter du pain (« je peux m'évanouir »), se laver les cheveux (« je vais mourir d'un cancer à cause du shampoing »). Cela correspond aux critères A et B du TAG : soucis excessifs présents la plupart du temps, portant sur de multiples domaines (santé, quotidien, travail, proches), vécus comme incontrôlables. Le critère C (3 symptômes sur 6) est partiellement documenté — difficultés de concentration au certificat ; fatigabilité, irritabilité et sommeil restent à vérifier, en tenant compte du fait qu'un nourrisson fragmente actuellement les nuits, ce qui parasite l'évaluation. Deux nuances : (1) une partie des soucis reste mieux expliquée par le TSA (adaptation sociale) et par l'agoraphobie (peur des crises) — clause d'exclusion du critère F ; (2) la **thématique santé est saillante** (cancer, évanouissement, mort) : une dimension de **crainte excessive d'avoir une maladie** (nosophobie/cancérophobie) mérite une évaluation en propre — le DSM-5 rattache ce contenu au TAG lorsque la santé est un souci parmi d'autres (ce qui semble le cas), et à la crainte excessive d'avoir une maladie s'il devient central. À confirmer formellement avec le Dr Isorni, mais le TAG comorbide est désormais l'hypothèse la plus probable — et c'est précisément une indication validée de la venlafaxine.

e) Anxiété sociale (phobie sociale) — 300.23 : NON RETENUE comme diagnostic séparé. Le critère I de l'anxiété sociale exclut explicitement les peurs « mieux expliquées par [...] un trouble du spectre de l'autisme ». La peur de Xavier n'est pas d'abord celle du jugement : c'est celle de *l'illisibilité* des situations (« comprendre ce qu'on me dit et comment la personne attend que je lui réponde ») — un déficit réel de décodage, pas une surestimation phobique. La littérature récente (2025) montre d'ailleurs que le camouflage autistique se distingue du camouflage de l'anxiété sociale par sa fonction : compenser un manque d'intuition sociale plutôt qu'éviter un jugement redouté.

f) Phobie spécifique de type sang-injection-accident — 300.29 (F40.23x) : FORTEMENT PROBABLE (diagnostic nouveau, proposé par la v2.0 de ce rapport). Les trois syncopes documentées surviennent **toutes en contexte de soins** : instillation d'un collyre mydriatique (ophtalmologiste, ~2024), pose d'un cathéter, fin d'une biopsie hépatique (juillet 2026). Or le DSM-5 décrit précisément ce mécanisme, propre à ce seul type de phobie (stimulus type : « aiguilles, actes médicaux invasifs ») : « ceux présentant une phobie spécifique de type sang-injection-accident présentent souvent un malaise vasovagal ou une réponse proche de l'évanouissement caractérisée par une accélération initiale brève de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle **suivie par une décélération de la fréquence cardiaque et une chute de la pression artérielle** », et ces sujets « montrent une propension particulière au malaise vasovagal (évanouissement) en présence du stimulus phobogène ». Environ 75 % des personnes ayant cette phobie ont des antécédents de syncope face au stimulus : **c'est la seule phobie qui fait réellement s'évanouir.**

Conséquence capitale de psychoéducation : **une attaque de panique « classique » ne fait pratiquement jamais perdre connaissance** — elle est sympathique (le cœur accélère, la tension *monte*), et la « peur de s'évanouir » y reste une peur. Quand l'évanouissement se produit réellement, le mécanisme est autre : réflexe **vasovagal** (parasympathique, la tension *chute*), typiquement déclenché par les stimuli médicaux, la douleur ou la vue du sang. Chez Xavier coexistent donc **deux mécanismes distincts** : des attaques de panique (transports, situations sociales — vingt ans de crises *sans* syncope) et une réponse vasovagale (contextes médicaux — avec syncopes). Sa phrase « les crises d'angoisse me font m'évanouir maintenant » fusionne les deux ; les décomposer avec le Dr Isorni (quelles crises, quels contextes, y a-t-il eu une syncope hors contexte médical ?) est essentiel, car **les parades sont différentes**. La boucle de l'épisode ophtalmologique (« j'ai pensé que j'allais avoir une crise d'angoisse, ce qui m'a angoissé, et je me suis évanoui ») est une escalade anticipatoire typique sur terrain vasovagal. Le DSM-5 note enfin que ces patients deviennent « réticents à avoir recours à des soins médicaux » — risque concret à anticiper (cf. §10.1), d'autant qu'un suivi somatique hépatique est en cours. Il existe une parade simple et validée : la **tension appliquée** (cf. §10.2).

Précaution : des syncopes répétées justifient par principe un débrouillage somatique simple (au minimum un ECG, avis du médecin traitant) pour ne pas attribuer à l'anxiété ce qui relèverait d'une cause cardiaque ou orthostatique — même si le pattern exclusivement procédural est très évocateur du mécanisme vasovagal, bénin en lui-même.

6.3 TDAH — question ouverte, à explorer proprement

Le certificat mentionne « trouble de la concentration, distractibilité ». Trois hypothèses concurrentes, chacune plausible :

1. **TDAH comorbide véritable** : le DSM-5 (contrairement au DSM-IV) autorise le double diagnostic TSA + TDAH, fréquent (co-occurrence substantielle chez l'adulte TSA). La scolarité effondrée du collège y ressemble ; chez l'adulte ≥ 17 ans, 5 symptômes d'inattention suffisent.
2. **Inattention anxieuse** : le DSM-5 (diagnostic différentiel du TDAH) distingue explicitement « l'inattention liée aux inquiétudes et aux ruminations observées dans les troubles anxieux » — or l'esprit de Xavier est « focalisé » en permanence sur l'auto-surveillance sociale, ce qui consomme la ressource attentionnelle.
3. **Attention autistique** : le DSM-5 (TSA) note que « les anomalies de l'attention (trop focalisée ou facilement distraite) sont fréquentes » dans le TSA sans constituer un TDAH ; l'hyperfocus (AQ 4) et la distractibilité sensorielle (AQ 5 : bruits discrets) en relèvent.

Éléments contre un TDAH franc : auto-description d'une capacité à revenir à sa tâche après interruption (AQ 37) et à mener plusieurs choses de front (AQ 32) ; effondrement scolaire concentré sur une période traumatique (violences, harcèlement, dépression) plus que trouble constant depuis avant 12 ans dans tous les contextes. **Recommandation : passation d'un DIVA-5 (entretien structuré TDAH adulte) avant toute conclusion — et avant tout traitement stimulant éventuel.**

6.4 Autres différentiels et points de vigilance

- **Trouble dépersonnalisation/déréalisation (dissociatif) : ÉCARTÉ** — les phénomènes surviennent au sein des attaques de panique (cf. §6.2.a), pas de façon autonome.
- **Schizophrénie / troubles psychotiques : ÉCARTÉS** — aucun élément hallucinatoire ou délirant ; la déréalisation paroxystique anxieuse n'en relève pas.
- **Trouble dépressif caractérisé : PAS D'ÉPISODE ACTUEL DOCUMENTÉ, mais antécédents plus lourds qu'initialement évalué (v2.0).** Xavier identifie rétrospectivement « de nombreuses dépressions » au collège **et au lycée** — clinophilie (rester au lit sans pouvoir en sortir), incapacité à investir la moindre activité pendant les vacances — soit des **épisodes dépressifs récurrents probables, jamais diagnostiqués**, s'ajoutant aux « forts mouvements dépressifs » du CM2 et à l'idéation suicidaire adolescente. Un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, est plausible ; la vigilance doit être durable (démoralisation de l'agoraphobie chronique, risque dépressif majoré du TSA adulte, période de surcharge actuelle). La venlafaxine couvre partiellement ce risque.
- **Risque suicidaire : à surveiller explicitement.** Antécédents adolescents avérés (rebord de fenêtre) ; le DSM-5 documente une majoration des idées et tentatives de suicide associée aux attaques de panique et au trouble panique, indépendamment des comorbidités. Rien n'indique une actualité suicidaire dans le dossier, mais ce point doit rester une question ouverte et régulière du suivi mensuel. (En cas de crise en France : **3114**, 24h/24.)
- **Trouble stress post-traumatique / trauma complexe : NON ÉVALUÉ, exploration légitime.** L'exposition prolongée de l'enfance (violences physiques et verbales multi-sources, précarité, foyer d'urgence, harcèlement scolaire) est un facteur étiologique indépendant plausible d'une partie de la symptomatologie anxieuse et de l'hypervigilance. Aucun symptôme de reviviscence n'est documenté — mais aucun n'a été recherché.
- **Énurésie nocturne jusqu'à 16 ans : antécédent significatif, résolu.** Le DSM-5 cite les « troubles sphinctériens » parmi les troubles associés au TSA à noter ; la persistance très tardive est aussi compatible avec le stress chronique du contexte familial. Rétrospectivement, c'était un signal d'alerte neurodéveloppemental et psychotraumatique passé inaperçu.
- **Pertes transitoires de la parole en surcharge (« shutdown » autistique) : phénomène à reconnaître, pas un trouble supplémentaire.** Lors de conflits ou de sur-sollicitation (notamment avec Chourouk), Xavier « perd la parole » et ne peut plus traiter la moindre demande. La littérature sur l'autisme adulte décrit ce phénomène comme un *shutdown* : réponse neurologique **involontaire** à la surcharge (sensorielle, émotionnelle, sociale), où la production de parole se coupe temporairement alors que la pensée et le langage intérieur restent présents. À distinguer du mutisme sélectif (trouble anxieux durable, contexte-spécifique — DSM-5 313.23, non pertinent ici) et, surtout, d'un refus de communiquer. Enjeu conjugal majeur : sans cette clé de lecture, l'entourage interprète le silence comme du rejet ou du mépris, ce qui escalade le conflit et prolonge le shutdown (protocole en §10.5). Une fréquence croissante de ces épisodes est aussi un signal d'alerte de burnout autistique.
- **Aphantasie : variante neurocognitive (non pathologique) à intégrer au profil.** Absence d'imagerie mentale visuelle (~1-4 % de la population selon le seuil retenu), avec imagination conceptuelle préservée — exactement la description de Xavier (« j'ai de l'imagination, mais aucune image visible dans la tête » : l'imagination n'implique pas l'imagerie, comme le montre

l'existence d'écrivains et de créateurs aphantasiques). Elle est statistiquement associée à l'autisme, ainsi qu'à une **mémoire autobiographique appauvrie** (jusqu'au tableau dit SDAM) — ce qui éclaire d'un jour nouveau l'anamnèse de Saley truffée de « aucun souvenir ne lui revient » : ces blancs sont probablement, au moins en partie, une caractéristique cognitive stable et non (seulement) de l'oubli ou de l'évitement traumatique. Conséquences pratiques : les techniques thérapeutiques fondées sur la visualisation (imagerie apaisante, exposition en imagination) sont **structurellement inopérantes** chez lui — privilégier l'exposition *in vivo*, le canal verbal et le canal corporel ; un VVIQ (questionnaire de vivacité de l'imagerie visuelle) permettrait de l'objectiver en cinq minutes.

7. Le diagnostic d'Emeline Saley est-il confirmé ?

OUI — confirmé, sur les trois plans possibles.

1. **Convergence externe** : trois professionnels indépendants, par trois méthodes différentes, aboutissent au même diagnostic — Dr Lamia Kias (clinique psychiatrique, février 2023), Emeline Saley (évaluation psychométrique et clinique structurée, avril 2024), Dr Jean-Baptiste Isorni (suivi médical mensuel, certificat du 21/11/2024 cochant exactement les trois déficits du critère A et le caractère restreint/répétitif du critère B). La condition suspensive que Saley elle-même posait (« la confirmation du diagnostic ne peut s'effectuer que par validation d'un psychiatre ») **a été levée le 21/11/2024.**
2. **Vérification interne** : la re-cotation indépendante des questionnaires (ce rapport) retrouve **exactement** ses scores (AQ 39/50, EQ 9/80) ; l'analyse critérielle DSM-5 menée ici à partir des données brutes aboutit à un TSA rempli de façon surdéterminée (A 3/3, B 4/4). Aucune donnée du dossier ne contredit la conclusion.
3. **Cohérence de la conclusion prudente** : son constat d'une présentation « légère » en entretien (interaction fluide, contact oculaire correct) n'affaiblit pas le diagnostic — c'est la présentation attendue d'un adulte de 38 ans à haut niveau de compensation, et le DSM-5 le prévoit littéralement (« les interventions, les compensations et aides actuelles sont susceptibles de masquer les difficultés »).

Limites méthodologiques de l'évaluation Saley (à connaître, sans portée sur la validité de la conclusion) :

- Pas d'outils de référence internationaux (**ADOS-2, ADI-R**) ni d'équipe pluridisciplinaire, alors que les recommandations HAS 2018 pour le diagnostic de TSA adulte privilégient une évaluation multidisciplinaire avec ces instruments (psychologue + psychiatre, appui possible du Centre de Ressources Autisme) ;
- Pas d'évaluation du fonctionnement intellectuel (WAIS-IV), du fonctionnement adaptatif, ni de profil sensoriel standardisé ;
- L'ASDI, conçu comme entretien clinicien, a été auto-complété ;
- Référentiel hybride daté (« Asperger d'après le DSM-IV et la CIM-10 ») ; « légère intensité » n'est pas une catégorie DSM-5 (la sévérité se code en niveaux de soutien 1-3, par domaine) ;

- Évaluation réalisée sur une seule journée + questionnaires à domicile ;
- Erreurs matérielles mineures (champs téléphone/e-mail inversés, « Empathy Quotidien », référence EQ datée 2001 au lieu de 2004) ; et la mise en couleur de la conclusion (« en rouge : critère absent, en bleu : présent ») a été perdue lors de la conversion du document — l'analyse du §6.1 reconstitue ce codage à partir des données brutes.

Verdict global : évaluation honnête, multi-sources et convergente, conclusion correcte et confirmée médicalement. Un bilan complémentaire structuré (type CRA — pour l'Île-de-France : CRAIF — avec ADOS-2 module 4, WAIS-IV, profil sensoriel) reste **optionnel** : utile pour affiner le profil et étayer les dossiers MDPH, nullement nécessaire pour valider un diagnostic déjà posé.

8. Synthèse diagnostique structurée

#	Diagnostic	Code	Statut
1	Trouble du spectre de l'autisme , sans déficit intellectuel associé, sans altération du langage, niveau 1 (« nécessitant de l'aide ») pour les deux domaines, associé à un trouble anxieux — correspond à l'ancien « syndrome d'Asperger »	299.00 (F84.0)	Confirmé (Kias 2023 ; Saley 04/2024 ; Isorni 21/11/2024)
2	Agoraphobie , avec attaques de panique attendues (incluant dépersonnalisation/déréalisation, symptôme 11), évolution ~23 ans ; cognition du critère B explicitement confirmée (« je peux m'évanouir »)	300.22 (F40.00)	Confirmé (Isorni ; critères DSM-5 vérifiés sur pièces)
3	Phobie spécifique, type sang-injection-accident , avec malaise vasovagal — 3 syncopes en contexte de soins (collyre mydriatique, cathéter, biopsie)	300.29 (F40.23x)	Fortement probable — proposé par la v2.0 de ce rapport, à confirmer par le Dr Isorni
4	Trouble d'anxiété généralisée — pensées anxieuses continues, multi-domaines, incontrôlables ; thématique santé saillante (dimension nosophobique/cancérophobie à évaluer en propre)	300.02 (F41.1)	Probable — critères A-B décrits par Xavier ; critère C à compléter en consultation
5	Trouble panique	300.01 (F41.0)	Écarté — aucune attaque inattendue (confirmation directe) ; attaques exclusivement attendues, rattachées à l'agoraphobie et à la phobie sang-injection-accident
6	TDAH de l'adulte (présentation inattentive)	314.00/01	À explorer (DIVA-5) — différentiel : inattention anxieuse ou attention autistique
7	Trouble stress post-traumatique / séquelles de trauma développemental	—	Non évalué ; exploration légitime (violences de l'enfance)

#	Diagnostic	Code	Statut
8	Antécédents : épisodes dépressifs récurrents probables (collège, lycée) avec idéation suicidaire adolescente ; maux de ventre anxieux depuis le CM2 ; énurésie nocturne jusqu'à ~16 ans (résolue)	—	À l'anamnèse ; vigilance dépressive et suicidaire au long cours
9	Caractéristiques associées : alexithymie probable (TAS-20), camouflage social intense (CAT-Q), aphantasie (variante neurocognitive, ± mémoire autobiographique appauvrie — VVIQ), shutdowns avec perte transitoire de la parole en surcharge	—	Fortement suggérés ; à quantifier

Traitement actuel : **venlafaxine (IRSN)**, reprise le **07/08/2026** après ~1 an de paroxétine marqué par une régression — le retour à la molécule qui avait fait ses preuves est pharmacologiquement rationnel (indications validées : dépression, TAG, anxiété sociale, trouble panique/agoraphobie) ; suivi psychiatrique mensuel ininterrompu (Dr Isorni) ; RQTH demandée (12/2024).

9. Ce que cette analyse apprend (qui ne figure dans aucun des documents pris isolément)

1. **Le « manque d'empathie » est un artefact de mesure et de perception.** Les 9 points de l'EQ proviennent *tous* d'items d'empathie affective et morale ; les zéros proviennent *tous* d'items de décodage. Xavier n'est pas indifférent aux autres — il ne les *lit* pas en temps réel. La réputation professionnelle (« prétention, sarcasme, froideur ») punit un déficit perceptif comme s'il était un choix moral. C'est démontrable, chiffres à l'appui, et cela change ce qu'il faut expliquer à un employeur, à une compagne, à une fille.
2. **Alexithymie probable — le chaînon manquant du dossier.** Échec au Faces Test malgré un Eyes Test correct, champ émotionnel « très entravé », apparence « insensible » : ce pattern évoque une alexithymie (difficulté à identifier et nommer ses propres émotions), présente chez ~50 % des personnes autistes (66 % en population clinique adulte) contre ~10 % en population générale — et c'est *elle*, plus que l'autisme en soi, qui prédit les difficultés de reconnaissance émotionnelle et une part de l'anxiété. Une TAS-20 (10 minutes) trancherait. Enjeu concret : une crise d'angoisse peut être une émotion non identifiée qui n'a trouvé que le canal corporel.
3. **Les crises « bizarres » ont un nom et un numéro.** Dépersonnalisation/déréalisation = symptôme n° 11 de l'attaque de panique du DSM-5, présent dans la liste officielle entre les paresthésies et la peur de devenir fou. Ni folie, ni dommage cérébral, ni dissociation pathologique autonome. Savoir cela réduit la peur de la peur — qui est le moteur même du trouble.
4. **17 ans : l'âge de début des crises de Xavier est l'âge moyen exact de début de l'agoraphobie selon le DSM-5.** Son tableau est un cas d'école : chronicité sans rémission spontanée (le DSM-5 donne ~10 % de rémission sans traitement), facteurs de risque d'enfance cochés (événements négatifs, climat familial dur). Vingt ans de crises ne signifient pas incurabilité : ils signifient absence de traitement *spécifique* jusqu'ici.

5. **Les thérapies passées n'ont pas « échoué » — leurs gains se sont érodés (correction v2.0).**

Les prises en charge par Catherine Gazeau (TCC, plus une technique de mouvements oculaires horizontaux — la description correspond à l'**EMDR**, thérapie de retraitement par stimulations bilatérales) ont eu **à chaque fois un effet important**, « quelques mois/années » de gain. Le tableau n'est donc pas celui d'un patient réfractaire, mais d'un réservoir qui se re-remplit : tant que la charge autistique quotidienne (décodage, sensorialité, camouflage) restait inconnue et non traitée, chaque bénéfice s'usait sous la charge. C'est une excellente nouvelle pronostique : **il répond aux thérapies ; il manquait la moitié du diagnostic.** Détail précieux : la quasi-« transe » obtenue sur simple consigne oculaire vers le bas (une induction par fixation oculaire classique) suggère une bonne réceptivité hypnotique — exploitable (hypnose pour les gestes médicaux, EMDR à stimulations tactiles ou auditives, compatibles avec l'aphantasie).

6. **Le camouflage est le pont entre l'autisme et l'anxiété.** Sa réponse libre au Groden (« mon esprit est focalisé sur ça, je ne sais jamais comment être ») décrit le *camouflaging* au sens de la recherche actuelle — dont l'intensité prédit anxiété, dépression et épuisement indépendamment des traits autistiques. Les transports et les réunions ne sont pas des peurs arbitraires : ce sont les lieux de camouflage maximal sans issue de secours. Réduire le *besoin* de camoufler (environnements explicites, télétravail, relations informées du diagnostic) est une action thérapeutique en soi.

7. **Un profil autistique « invisible » dans les stéréotypes.** Pas de fascination pour les chiffres, les dates ou les collections ; imagination préservée ; sous-échelles sociales à 10/10. Ce profil — social-communicationnel et rigidité, sans folklore systématiser — est celui qui traverse l'école, les couples et les entreprises sans être repéré. Le diagnostic à 38 ans n'est pas un retard anormal : c'est la conséquence logique de ce profil, dans une génération (né en 1986) où l'Asperger n'est entré dans les classifications qu'en 1993-1994.

8. **La discordance mère/adulte est une donnée, pas une contradiction.** L'échelle Attwood maternelle cote 0 les intérêts restreints de l'enfance alors qu'ils sont le trait le plus constant de la vie de Xavier. Mémoire lointaine, chaos familial, intérêts « banals » pour l'époque (ordinateur) : le DSM-5 anticipe ce cas et ne fait pas de l'anamnèse parentale lacunaire un obstacle. À l'inverse, ce que la mère *a* retenu (balancements, indifférence aux pairs, expression émotionnelle non modulée) est d'autant plus probant.

9. **L'énurésie nocturne jusqu'à 16 ans était un signal.** Rarement reliée après coup, elle est cohérente à la fois avec le stress chronique majeur (violences, précarité) et avec le terrain neurodéveloppemental (le DSM-5 liste les troubles sphinctériens parmi les associations du TSA). Elle date la souffrance : le corps la signalait déjà pendant tout le collège.

10. **« Distractibilité » a trois explications concurrentes, pas une.** TDAH comorbide (possible, désormais diagnosticable avec le TSA depuis le DSM-5), inattention anxieuse (le DSM-5 la distingue explicitement), ou attention autistique (hyperfocus + capture sensorielle). Trancher par DIVA-5 avant d'y mettre un traitement — d'autant que ses propres réponses (AQ 32, 37) plaident contre un TDAH massif.

11. **Le trauma d'enfance mérite son propre chapitre.** Violences multi-sources, précarité, foyer d'urgence, harcèlement : même chez une personne autiste, tout ne s'explique pas par l'autisme. L'agoraphobie est statistiquement liée aux adversités précoces ; l'hypervigilance sociale peut être double (autistique *et* traumatique). Une exploration TSPT/trauma complexe par le Dr Isorni ou un psychologue formé est légitime — et n'a jamais été faite.

12. « **Léger** » est un mot piégé. En DSM-5, la sévérité se code en niveaux de soutien (ici : niveau 1 × 2 domaines), et le manuel interdit explicitement d'utiliser ces niveaux pour attribuer ou refuser des droits. Un TSA « léger » avec agoraphobie, crises et menace sur l'emploi justifie pleinement la RQTH et les aménagements — le certificat Isorni l'a bien compris.
13. **La cartographie du stress donne le plan d'action.** Catégories hautes : social/environnement (3,67) et sensoriel (3,50) → cibles d'aménagement. Catégorie basse : « positif » (1,50) → les renforçateurs fonctionnent normalement. Traduction : il n'y a rien à « motiver » chez Xavier ; il y a des charges à réduire. Un environnement prévisible, calme et explicite est son équivalent d'une rampe d'accès.
14. **S'évanouir n'est pas la suite logique d'une attaque de panique — c'est un autre circuit (v2.0).** La panique est sympathique : cœur qui accélère, tension qui *monte* ; on craint de s'évanouir mais on ne s'évanouit presque jamais — vingt ans de crises dans les transports sans une seule syncope le prouvent chez lui. Les syncopes réelles (collyre, cathéter, biopsie) relèvent du réflexe **vasovagal** — le profil exact de la phobie de type sang-injection-accident du DSM-5, la seule phobie qui fasse réellement perdre connaissance (réponse diphasique ; ~75 % d'antécédents de syncope). Deux circuits, deux parades : pour la panique, l'exposition ; pour le vasovagal, la **tension appliquée** (contracter fortement bras-jambes-tronc par salves de 10-15 secondes dès les premiers signes de malaise, pour faire remonter la tension artérielle) — technique validée, enseignable en une séance, à utiliser à chaque geste médical, en position allongée et en prévenant les soignants.
15. **L'aphantasie explique trois bizarreries du dossier d'un coup (v2.0).** (1) La contradiction AQ : item 3 « facile de me représenter une image » (répondu au sens conceptuel — les aphantasiques découvrent souvent très tard que « voir dans sa tête » est littéral pour les autres) contre item 8 « incapable d'imaginer l'apparence des personnages » (cohérent avec l'aphantasie). (2) L'anamnèse Saley saturée de « aucun souvenir ne lui revient » : l'aphantasie est associée à une mémoire autobiographique appauvrie (jusqu'au SDAM) — ces blancs sont probablement une caractéristique cognitive, pas seulement de l'oubli. (3) La coexistence d'une vraie créativité (il invente des histoires, il crée des jeux) sans images : imagination et imagerie sont deux fonctions dissociables. Conséquence thérapeutique directe : toute technique fondée sur la visualisation est inopérante — exiger de lui qu'il « imagine la scène » est un non-sens ; exposition in vivo, verbalisation, ancrages corporels.
16. **Perdre la parole n'est pas se taire contre quelqu'un (v2.0).** Les épisodes où il « n'arrive plus à parler ni à gérer la moindre sollicitation » (notamment avec Chourouk) correspondent au *shutdown* autistique : coupure involontaire et temporaire du canal verbal sous surcharge — la pensée reste là, le canal est coupé. Le pire traitement est l'insistance (« réponds-moi ! ») ; le bon est un protocole convenu à froid : signal minimal (mot-code, geste, SMS), retrait sensoriel court, reprise différée de la discussion. Pour un couple avec un nourrisson, ce protocole n'est pas un luxe : c'est de la prévention de crise.
17. **2026 n'est pas une rechute mystérieuse, c'est une addition (v2.0).** Mariage (2025), naissance (2026), nuits fragmentées, pleurs de nourrisson (charge sensorielle maximale à domicile — son refuge historique), trois missions simultanées, lien rompu avec l'aînée, parcours somatique avec biopsie : chaque élément est, isolément, un stressor majeur au regard de son profil Groden (changement, sensoriel, sollicitations). La régression sous paroxétine s'est produite *dans ce contexte* — elle ne prouve pas à elle seule que la molécule était en cause, mais

le retour à la venlafaxine (qui avait fait ses preuves et couvre TAG + agoraphobie) est le choix rationnel. Le risque à nommer aujourd'hui est le **burnout autistique** ; la variable d'ajustement disponible est la charge professionnelle (3 missions), pas la famille ni le sommeil.

18. **La rupture avec sa fille aînée est un deuil actif, pas un dossier clos (v2.0).** Deux médiations ont échoué, la seconde sans elle : à 14 ans, c'est elle qui tient la porte, et rien dans ce dossier ne permet d'attribuer des causes — ce rapport ne le fait pas. Ce qu'il permet de dire : ce lien rompu est une charge psychique permanente de premier plan, à nommer en thérapie comme telle ; les canaux à faible intensité (message ou lettre ponctuelle, sans exigence de réponse) sont la meilleure façon de laisser une porte ouverte sans pression ; et le diagnostic de son père — expliqué un jour avec des mots justes — pourrait à terme transformer sa lecture des années de conflit. Patience structurée, plutôt qu'espoir passif ou renoncement.
-

10. Recommandations

10.1 Médical (avec le Dr Isorni)

- **Reprise de la venlafaxine (07/08/2026)** : titration progressive jusqu'à la dose antérieurement efficace, délai d'action à respecter (2 à 4 semaines par palier — ne pas conclure trop tôt), **jamais d'arrêt brutal** (syndrome d'arrêt marqué avec cette molécule) ; surveillance tensionnelle aux paliers hauts. Point notable : une molécule légèrement hypertensive n'est pas un mauvais profil chez un patient à malaises vasovagaux (où la tension chute).
- **Syncope — double action.** (1) Débrouillage somatique simple pour ne rien manquer : ECG au minimum, avis du médecin traitant, bilan orthostatique si doute. (2) Si le bilan est normal — ce que le pattern exclusivement procédural laisse attendre — traiter comme réflexe vasovagal sur phobie de type sang-injection-accident : **tension appliquée** apprise puis utilisée à chaque geste, gestes invasifs en **position allongée**, et **prévenir systématiquement les soignants** (« je fais des malaises vagues lors des gestes médicaux »). Objectif explicite : empêcher l'évitement des soins (risque documenté du DSM-5 pour cette phobie), crucial avec un suivi hépatique en cours.
- Questions à trancher en consultation : confirmation du **TAG** (compléter le critère C : sommeil, fatigabilité, irritabilité — en tenant compte du nourrisson) ; confirmation de la **phobie sang-injection-accident** ; évaluation de la dimension **nosophobique** (cancérophobie) ; dépistage TDAH (DIVA-5) ; exploration du versant traumatique ; évaluation périodique de l'humeur et du risque suicidaire (antécédents adolescents + attaques de panique = facteurs de risque documentés), avec attention particulière à la charge actuelle (deuil du lien avec l'aînée, surcharge du foyer).
- Suivi somatique : poursuivre le parcours hépatique engagé (biopsie de juillet 2026) avec le prescripteur concerné — ce rapport n'en connaît pas l'indication et ne spécule pas ; signaler le terrain vasovagal avant tout nouveau geste.

10.2 Psychothérapeutique

- **TCC de l'agoraphobie adaptée au double profil TSA + aphantasie** : psychoéducation des 13 symptômes de l'attaque (dont le n° 11), exposition graduée aux transports avec paliers écrits et prévisibles, outils sensoriels intégrés (casque à réduction de bruit, heures creuses, trajets répétés à l'identique), travail sur la peur de la peur — **exclusivement en exposition réelle, verbale et corporelle** (aucune technique de visualisation : structurellement inopérante chez un aphantasique).
- **Tension appliquée (méthode d'Öst)** pour le versant vasovagal : apprentissage en une à deux séances (cycles de contraction musculaire globale de 10-15 secondes dès les prodromes), puis application systématique lors des gestes médicaux — traitement de référence validé de la phobie sang-injection-accident avec syncope.
- **Reprendre contact avec Catherine Gazeau est une option rationnelle** : elle connaît le dossier, obtenait des effets réels, et disposerait désormais des pièces manquantes (diagnostic TSA, aphantasie, mécanisme vasovagal). L'EMDR peut se poursuivre avec **stimulations bilatérales tactiles ou auditives** (compatibles avec l'aphantasie) sur le matériel traumatique de l'enfance ; la bonne réceptivité hypnotique observée ouvre aussi l'**hypnose** comme outil pour les gestes médicaux.
- Travail complémentaire : identification émotionnelle (si TAS-20 positive), pacing de l'énergie sociale (prévention du burnout autistique), **accompagnement du deuil relationnel concernant sa fille aînée**, affirmation du diagnostic auprès des tiers choisis.

10.3 Bilans complémentaires utiles (aucun n'est bloquant)

Outil	Objet	Priorité
TAS-20	Alexithymie	Haute (10 min, fort rendement explicatif)
CAT-Q	Intensité du camouflage	Haute
DIVA-5	TDAH adulte	Haute si la plainte attentionnelle persiste
WAIS-IV	Profil cognitif (forces/hétérogénéité)	Moyenne
Profil sensoriel de Dunn (adulte)	Cartographie sensorielle pour les aménagements	Moyenne
VVIQ	Objectivation de l'aphantasie (vivacité de l'imagerie visuelle)	Haute (5 min ; conditionne les techniques thérapeutiques utilisables)
Bilan CRA (CRAIF) avec ADOS-2 module 4	Confirmation instrumentale « gold standard »	Optionnelle (diagnostic déjà posé)

10.4 Travail et RQTH

- **L'aménagement central est déjà acquis** : depuis la création d'« Allons-y » (2022), Xavier travaille en indépendant, en télétravail complet — la configuration qui neutralise les transports (situation agoraphobogène n° 1) et l'immersion sociale continue. C'est un aménagement auto-

construit remarquablement ajusté, à protéger ; la RQTH reste utile comme filet (aménagements opposables en cas de retour au salariat, appuis MDPH).

- **Le risque principal n'est plus la rupture de mission, c'est la surcharge** : 3 missions simultanées + un nourrisson. Leviers concrets : plafonner le nombre de missions actives, sanctuariser des plages sans réunion, ménager des tampons entre visioconférences, refuser les urgences artificielles — la variable d'ajustement doit rester professionnelle, pas familiale ni le sommeil.
- En présentiel résiduel (rendez-vous clients, présentations — stresser identifié au Groden) : horaires hors pointe, ordre du jour écrit, attentes explicites, un interlocuteur référent, feedback direct et littéral.
- Capitaliser sur la compétence technique unanimement reconnue — « d'un point de vue technique, rien ne lui sera jamais reproché ».

10.5 Quotidien et entourage

- **Protocole shutdown avec Chourouk, négocié à froid** : un signal minimal convenu (mot-code, geste, SMS) signifiant « canal verbal coupé — ce n'est pas contre toi », un droit de retrait sensoriel court et légitime, une reprise différée et planifiée de la discussion. À froid également, lui transmettre les deux messages centraux de ce rapport : l'empathie affective est intacte (§9.1), et le silence sous surcharge est neurologique, pas relationnel (§9.16).
- Négocier des **zones de routine protégées** à la maison (rangement) contre des zones de liberté pour Chourouk ; annoncer les changements à l'avance. Avec un nourrisson : répartition explicite des charges sensorielles (roulement pour les pleurs et les nuits), protection d'un créneau quotidien de récupération sans sollicitation.
- **Fille aînée** : maintenir un canal à faible intensité (message ou lettre ponctuelle, sans exigence de réponse), ne pas ré-empiler les dispositifs de pression (les médiations ont montré leur limite actuelle), et travailler ce deuil actif en thérapie (§9.18).
- Hygiène anxieuse : caféine à limiter (panicogène documenté), activité physique régulière, sommeil protégé autant que possible, pas d'automédication (alcool : risque documenté dans l'agoraphobie), budget de récupération après les événements sociaux.
- Surveiller les signes de **burnout autistique** (épuisement profond, perte de compétences habituelles, intolérance sensorielle accrue, retrait massif) — **la fréquence des pertes de parole est le meilleur indicateur de suivi** : en parler chiffres en main au Dr Isorni.

10.6 Forces sur lesquelles construire

Expertise technique d'exception et **entrepreneuriat réussi** (« Allons-y », 3 missions simultanées — l'aménagement dont il avait besoin, il l'a construit lui-même) ; mémoire à long terme remarquable ; intégrité morale forte et fiabilité (EQ items 13, 20 ; ponctualité) ; capacité d'hyperfocus productif ; autonomie complète ; **réactivité démontrée aux thérapies** (gains réels et répétés avec Catherine Gazeau, bonne réceptivité hypnotique) ; fratrie soudée, mariage (2025), paternité renouvelée (2026) ; et une démarche diagnostique menée à terme à 38 ans — ressource identitaire : vingt ans de « je ne sais jamais comment être » ont désormais une explication, un nom, un cadre légal (RQTH) et des leviers.

11. Références

Documents internes

- ressources/xavier/Evaluation Xavier.md — Emeline Saley, 05/04/2024
- ressources/xavier/Dossier RQTH.md — Cerfa 15692*01 + certificat Dr J.-B. Isorni (21/11/2024) + attestation ENGIE
- ressources/xavier/Quotient du Spectre Autistique QA.md ; Quotient d'Empathie EQ.md ; Echelle-syndrome-Asperger.md ; Inventaire-du-stress.md ; Question-aux-parents.md
- ressources/spécialisées/DSM-5_TSA.md ; DSM-5_TDAH.md ; DSM-5_Anxiodepressif.md

Littérature et ressources en ligne (consultées le 08/08/2026)

- AQ — psychométrie et seuils : [Baron-Cohen et al., 2001 — synthèse et données \(Embrace Autism\)](#) ; [Utilité de l'AQ en dépistage TSA \(BMC Psychiatry, 2023\)](#) ; [AQ dans un demi-million de personnes \(PLOS One\)](#).
- EQ — construction et normes : [Baron-Cohen & Wheelwright, 2004 \(JADD\)](#) ; [Lawrence et al., 2004 — validité de l'EQ \(PDF\)](#) ; [synthèse Embrace Autism](#)
- Camouflage social : [Hull et al., 2021 — camouflage, anxiété et dépression \(Molecular Autism\)](#) ; [Revue systématique des conséquences du camouflage \(2025\)](#) ; [Camouflage TSA vs anxiété sociale \(PMC, 2025\)](#) ; [Camouflage et burnout autistique — revue \(2026\)](#).
- Comorbidité anxieuse du TSA adulte : [Hollocks et al., 2019 — méta-analyse \(Psychological Medicine\)](#) ; [Étude en population \(JADD, 2020\)](#) ; [Symptômes panique-agoraphobiques dans le TSA \(CNS Spectrums\)](#).
- Alexithymie : [Alexithymie chez les adultes autistes en service clinique — 66,3 % \(PMC, 2023\)](#) ; [Ola & Gullon-Scott, 2020 — la reconnaissance faciale corrèle avec l'alexithymie, pas l'autisme \(Autism\)](#) ; [Alexithymie & autisme — vulgarisation FR \(AIDE Canada\)](#).
- Parcours diagnostique français : [HAS — TSA de l'adulte : recommandations](#) ; [HAS — interventions et parcours de vie de l'adulte](#) ; [Maison de l'autisme — parcours diagnostique](#) ; [CRAIF — diagnostic adulte](#)
- Venlafaxine : [Venlafaxine XR dans le trouble panique \(PMC\)](#) ; [Guide pharmacologique \(Psychopharmacology Institute\)](#) ; [Fiche patient \(Mayo Clinic\)](#).
- Phobie sang-injection-accident et syncope vasovagale : [Vue d'ensemble BII phobia \(ScienceDirect Topics\)](#) ; [Traitements de la phobie sang-injection-blessure — revue critique \(2009\)](#) ; [Tension appliquée — cas clinique sévère \(Mednick & Claar, 2012\)](#) ; [Tension appliquée — guide pratique \(PsychCentral\)](#) ; [Exposition + tension appliquée \(Frontiers in Psychology, 2018\)](#).
- Aphantasie : [Aphantasie et hyperphantasie — revue \(Trends in Cognitive Sciences, 2024\)](#) ; [Aphantasie, synesthésie et autisme \(Dance et al., 2021\)](#) ; [Prévalence de l'aphantasie en population générale](#) ; [Aphantasie et mémoire autobiographique très déficitaire \(SDAM\)](#) ; [Se souvenir avec un « esprit aveugle » \(Cognition, 2022\)](#).
- Shutdowns autistiques : [Guide du shutdown autistique \(Reframing Autism\)](#) ; [Meltdowns et shutdowns \(NHS Leicestershire Partnership\)](#) ; [Mutisme situationnel chez l'adulte autiste \(Embrace Autism\)](#).

Fin du rapport — version 2.0, 08/08/2026 (v1.0 le même jour ; révision intégrant les compléments anamnestiques directs de Xavier). Document personnel et confidentiel de Xavier Boubert.